

教育心理学教师素养课程

第十章 学生心理健康

第一节 认识心理健康

第二节 情绪与心理健康

第三节 常见的心理问题

第四节 心理健康的促进

第一节 认识心理健康

(一) 心理健康的概念内涵

- **心理健康**：通常指的是一种积极、持续的心理状态，而不仅仅是未疾患精神疾病
 - 具有积极的生命活力，拥有积极的内心体验，具有良好的社会适应能力
 - 能高效地发挥自己的身心潜力，实现更多积极的社会功能
- 《关于加强心理健康服务的指导意见》则界定为：人在成长和发展过程中，认知合理、情绪稳定、行为适当、人际和谐、适应变化的一种完好状态。



(二) 心理健康的衡量标准

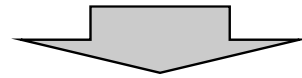
■ 不同学者对心理健康的衡量标准存在一定差异

马斯洛等人(Maslow & Mittelman, 1951)的十条标准:

1. 个人基本需要的恰当满足(不违背社会规范前提下)
2. 足够的安全感
3. 保持人格的完整和谐
4. 充分了解自我, 对自己的能力有合适的自我评价
5. 适度的情绪表达与控制
6. 保持良好人际关系
7. 保持与现实环境的接触
8. 能够从经验中学习的能力
9. 能进行有限度的个人发挥(不违背团体要求)
10. 生活目标切合实际

林崇德教授提出六项原则(2000):

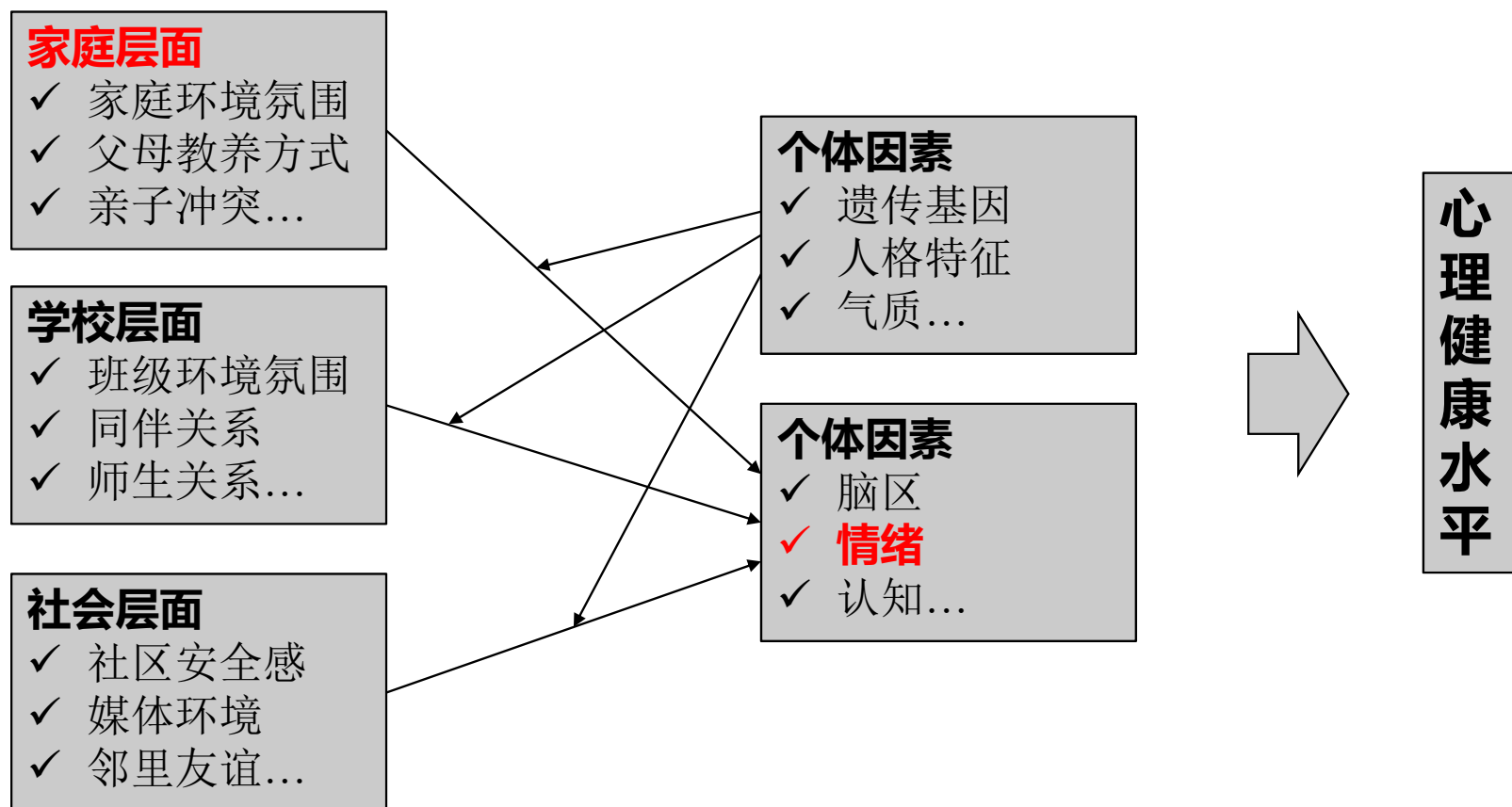
1. 善于正确地评价自我
2. 通过别人来认识自己
3. 及时而正确地归因, 达到认识自我的目的
4. 具有自制力
5. 扩展自己的生活经验
6. 根据自身实际情况确立抱负水平



自我: 适度地自我认知
情绪: 良好的情绪控制与调节
关系: 良好的人际关系

环境适应: 良好的环境适应能力
未来发展: 完善的自我发展目标

二、心理健康的影响因素



第二节 情绪与心理健康

一、如何界定情绪 (emotion) ?

- 情绪是个体应对某个刺激产生的**复杂反应序列**，包含认知评价、感受、行为和生理变化等方面 (Ekman, 1992; Lazarus, 1991, et al.)

认知评价：对特定刺激如何影响自身目标、福利和关切的评估

生理变化：神经生物层面的改变，如神经兴奋、脑电波变化等

心理感受：个体的主观体验 **行为反应**：个体在面对特定刺激时做出的动作反应

一、如何界定情绪 (emotion) ?

■ 在效价上，情绪包括积极情绪和消极情绪两个方面

积极情绪：与接近行为相伴随，与需求满足和目标实现相联系，如快乐、兴趣、爱等

消极情绪：与回避行为相伴随，是生活事件对心理产生的负面影响，如痛苦、悲伤、愤怒等

■ 从类型上，情绪可以分为基本情绪和复合情绪（或复杂情绪）

基本情绪：与生俱来，婴儿早期表现出来，具有独特适应功能

如快乐、悲伤、恐惧、厌恶等

复合情绪：也叫自我意识情绪，与生活经历有关，

需要自我的感知和认知能力来评判，

如尴尬、嫉妒、内疚、害羞等

二、情绪的生理机制

■ 情绪的自主神经机制

- ✓ **自主神经系统**：控制各种腺体和器官，由交感和副交感神经系统组成
- ✓ 测量自主神经系统活动，可以反应情绪的生理层面变化

指标	测量方法	与情绪对应的反应模式
心率	单位时间内心脏搏动的次数	在放松状态下，副交感神经的功能占优势，表现之一是心率变慢。在情绪唤醒状态下，副交感神经系统的兴奋性下降，交感神经的兴奋性增强，心率加快。
皮肤电导水平	通过生理多导仪采集，收集人体皮肤上两点之间（通常是手指）的电位差	在情绪唤醒状态下，皮肤电阻下降，皮肤电水平升高。一般而言，皮肤电水平较高的个体表现为较高的焦虑、紧张、情绪不稳定。
手指温度	通过便携式温度感应器，收集处于手指多个位置点的温度	在情绪唤醒状态下，交感神经兴奋，指端的血流量减少，从而导致指温降低。相反，处于平静状态下的个体，手指血流量增加，因此指温升高。
.....		

二、情绪的生理机制

■ 情绪的**中枢**神经机制

- ✓ **中枢神经系统**：包含脑和脊髓，通过测量情绪产生时的脑活动可理解情绪的生理机制
- ✓ 常见技术手段包括脑电图、功能性磁共振成像、脑磁图等

脑区	与情绪相关的表现
下丘脑	通过影响自主神经系统和内分泌调节与生命体正常运转相关的因素，如体温、水分、血糖、血氧、盐分等。在负性情绪和压力状态下，通过调节身体多个方面帮助个体做相应的准备。
杏仁核	恐惧情绪反应中枢，在情绪加工中起关键作用。高兴、惊奇等积极情绪也可激活杏仁核，但激活程度不如恐惧、焦虑等负性情绪
前额叶皮层	掌管计划、工作记忆、冲动抑制等与决策有关的高级认知功能，负责对情绪的评价、重新解释等调节作用。前额叶受损容易影响情绪调节能力，导致出现冲动决策。此外，前额叶皮层的活跃程度可抑制杏仁核的活动，从而降低情绪强度，帮助个体冷静下来做决策。
.....	

三、情绪的发展

(一) 情绪的分化

阶 段	关键时间	发展与分化表现
婴儿期： 基本情绪的分化	刚出生	能够表现出好奇、痛苦、厌恶、满足等情绪
	2个月左右	首次出现社会性微笑，这是婴儿情绪社会化的开端
	2-7个月	表现出愤怒、恐惧、快乐、悲伤、惊讶
幼儿期和学龄期： 复杂情绪的分化	2岁左右	发展出尴尬、害羞、内疚、嫉妒、骄傲等需要自我评价的情绪
	4-5岁	随着心理理论的掌握，尴尬、羞耻、内疚等情绪得到发展
	6/7-11/12岁 即小学阶段	随着语言的发展，可以更加有效地用语言表达情绪、讨论过去发生的情绪事件或他人情绪经历，预测可能发生的情绪感受。
青少年期	11/12-17/18 即初高中阶段	情绪强度高、起伏大，具有更多的极端而短暂的情绪 容易出现抑郁、焦虑、孤独感等情绪问题 情绪感受更加丰富、深刻，社会性情绪占主导地位 情绪调节能力不断发展，但仍不稳定，具有波动性

三、情绪的发展

(二) 情绪的社会化与调节

- ✓ **情绪的社会化**：指个体习得在特定场合中情绪的表达规则，即哪些情绪是可以表达的，哪些情绪是不适合表达的，并对自身的情绪进行调节
- ✓ **情绪调节**：对情绪表达的调整和管理，包括对情绪唤醒的抑制、维持或增强

婴儿：往往通过肢体表达、与他人互动、玩玩具或逃离回避等方式调节消极情绪

较小的儿童：喜怒哀乐表现得比较直接，情绪调节能力较弱。

青少年：情绪调节能力有所提升，但仍容易受负面情绪影响，难以自我调节。

大学生(成年早期)：情绪表达和控制能力趋于成熟，能采用更多情绪调节策略应对问题。

第三节 常见的心理问题

一、心理问题的定义

- **心理问题：**由现实问题或冲突等引起的情绪、睡眠和行为等方面的不良改变。
 - ✓ **当心理问题程度较低时**，这种心理上的改变通常是短暂的、轻微的，可以主动寻找原因，积极调整自己的行为
 - ✓ **当心理问题程度较重时**，可能发展成为心理障碍，即心理、行为显著偏离正常，甚至出现精神病性症状、社会功能下降，个体感到精神痛苦
 - ✓ 广义语境下的心理问题，一般同时包括上述两者

二、常见心理问题的症状与评估

■ 适应问题

- ✓ **适应**：指当外界环境发生改变时，个体能够通过改变自身去顺应环境，从而与环境保持相互协调、和谐共处的状态
- ✓ **适应问题**：指个体在适应环境过程中出现的各种不良适应状态。例如，新生入学后会面临生理适应、心理适应、学习适应、社会适应等一系列问题。

心理适应：面对新环境的不良刺激，能否主动改变原有认知结构，实现内部认知与外部环境相互协调

生理适应：面对入学后不良环境，能否积极调节自身生理机制，以适应新环境带来的刺激

学习适应：指能否根据环境及学习的需要，努力调整自我以达到与学习环境的平衡

社会适应：能否主动采取措施消除社会环境对自身的不利影响，积极克服现实困难，实现自身需求

二、常见心理问题的症状与评估

■ 抑郁障碍 (Depression disorder, 也称抑郁症)

- ✓ **定义：**是一种以心情低落、无望失望为主要症状的情绪障碍
- ✓ **核心症状：**情绪低落、思维迟缓、言语动作减少和迟缓
- ✓ **其他症状：**还可能伴有入睡困难、食欲不振、倦怠无力、躯体慢性疼痛等
儿童青少年，还可能伴有烦躁、易激惹

二、常见心理问题的症状与评估

《精神障碍诊断与统计手册》(DSM-5)中，抑郁障碍的核心症状（2条）与伴随症状（7条）

- ① 几乎每天大部分时间都出现心境抑郁（如悲伤、无望、哭泣、流泪等）；
- ② 几乎所有的活动兴趣和乐趣都明显减少（就像“骑车没油了”“机器没电了”）；
- ③ 体重明显减轻或明显增加（如一个月内体重变化超过原体重的5%）；
- ④ 几乎每天都失眠或睡眠过多；
- ⑤ 几乎每天都精神运动性激越或迟缓（需要他人观察所见）；
- ⑥ 几乎每天都疲劳或精力不足；
- ⑦ 几乎每天都感到自己毫无价值，或过分地、不适当地感到内疚；
- ⑧ 几乎每天都存在思考，注意力集中的能力减退或犹豫不决（可以是主观体验，也可以是他人观察）；
- ⑨ 反复出现死亡的想法（而不仅仅是恐惧死亡），反复出现没有特定计划的自杀意念，或有某种自杀企图，或有某种实施自杀的特定计划。

二、常见心理问题的症状与评估

■ 焦虑障碍 (Anxiety disorder, 也称焦虑症)

- ✓ **焦虑情绪**：是个体面对压力、危险或不熟悉情况时产生的不安、苦恼或恐惧等情绪反应。适度焦虑有助于保持警觉和注意，过度焦虑则带来消极后果。
- ✓ **焦虑障碍**：过度的恐惧或焦虑，并产生消极的行为和情绪后果。
- ✓ 我国学龄儿童和青少年中，焦虑障碍的患病率约为4.7%，女孩更高(Li et al., 2022)
 - **广泛性焦虑障碍**
 - 社交焦虑障碍
 - 广场恐惧症
 - 分离焦虑障碍
 - 惊恐障碍
 -

二、常见心理问题的症状与评估

■ 焦虑障碍 (Anxiety disorder, 也称焦虑症)

- ✓ **广泛性焦虑障碍**：表现为在至少六个月的多数日子里，对诸多事件或活动表现出过分的焦虑和担心（焦虑性期待），并难以控制这种担心。

《精神障碍诊断与统计手册》：过去半年中至少出现以下6重症状中的3种，儿童只需1种

- ① 坐立不安或感到激动或紧张
- ② 容易疲劳
- ③ 注意力难以集中，或头脑一片空白
- ④ 易激惹
- ⑤ 肌肉紧张
- ⑥ 难以入睡或保持睡眠状态，或休息不充分的、质量不高的睡眠

二、常见心理问题的症状与评估

■ 强迫症 (Obsessive-compulsive disorder)

- ✓ **界定：**包括强迫思维和强迫行为
- ✓ **强迫思维：**指强迫性的、侵入性的思想，如总是担心自己没有关好门窗
- ✓ **强迫行为：**为了缓解与强迫性想法有关的焦虑而引发的行为，如反复关门

二、常见心理问题的症状与评估

《精神障碍诊断与统计手册》(DSM-5)中，强迫症表现为具有强迫思维或强迫行为，或两者都有

强迫思维：

- ① 在该症状的某些时间段内，感受到反复的、持续的、侵入性的和不必要的想法、冲突或表象，大多数个体会出现显著的焦虑或痛苦；
- ② 个体试图忽略或压抑此类想法、冲动或表象，或用其他一些想法或行为来缓和它们，如通过某种强迫行为。

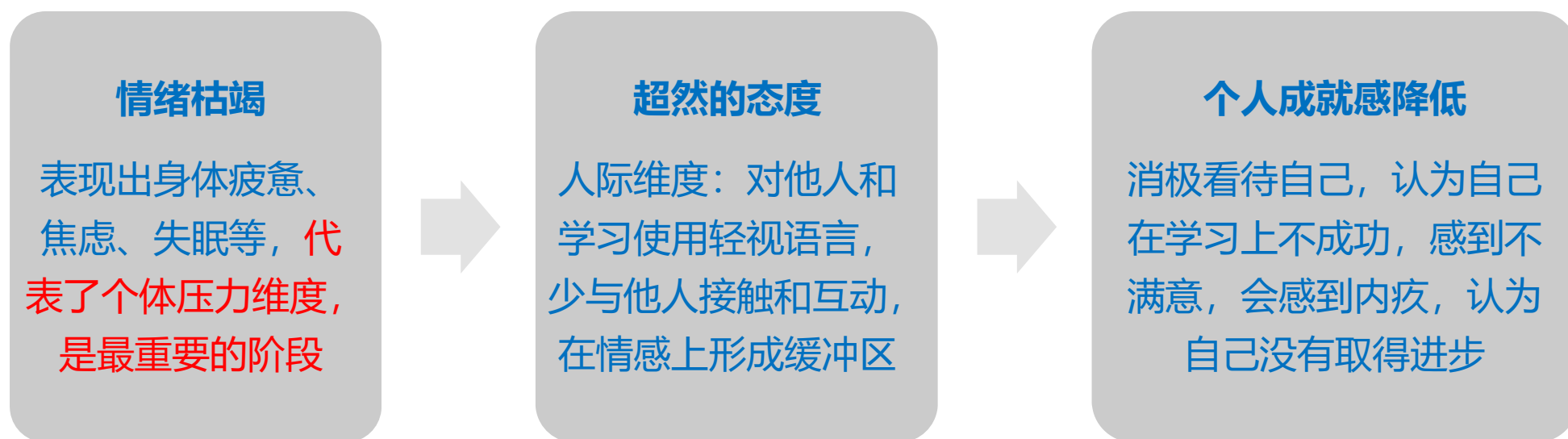
强迫行为：

- ① 重复行为（如关门、洗手）或精神活动（如计数、反复默诵字词）。个体感到重复行为或精神活动是作为应对强迫思维或根据必须严格执行的规则而被迫执行的。
- ② 强迫行为的目的是防止或减少焦虑或痛苦，或防止某些可怕事件或情况，但二者之间缺乏现实的连接，或者明显是过度的，无法达到缓解效果。反而消耗大量时间，可能引起具有临床意义的痛苦，或导致社交、职业或其他重要功能的损害。

二、常见心理问题的症状与评估

■ 学业倦怠 (Academic burnout)

- ✓ **界定：**指的是由于学业要求而产生的疲惫，对学业的愤世嫉俗和超然的态度，以及作为学生的不充实感(Walburg, 2014)



三、常见心理问题的治疗

■ 心理问题的治疗通常包括药物治疗和心理治疗

- ✓ **药物治疗**：治疗药物均为处方药，只有精神科医生才能开药。服用药物要谨遵医嘱，定期复查，不可擅自增减药物。
- ✓ **心理治疗**：是运用心理学原理和方法，由专业人员有计划地实施的治疗技术，属于医疗行为。心理治疗人员：精神科执业(助理)医师并接受了规范化的心理治疗培训，或通过卫生专业技术资格考试(心理治疗专业)并取得资格者。
- ✓ **心理咨询**：由专业受训的心理咨询师运用心理学的方法，对心理适应方面出现问题并企求解决问题的求助者提供心理援助，并尽可能扩大个人潜力得以发展的过程(张小乔, 2003)。不属于医疗范畴。

第四节 心理健康的促进

- 心理健康教育
- 心理问题咨询
- 心理危机干预

一、心理咨询的常见流派

■ 精神分析/动力学取向

- ✓ 主要关注个体在无意识层面传递的信息，把压抑在潜意识中的想法带到意识层面，帮助来访者对过去经历之间的关系有新的理解，产生顿悟，打开心结或冲突
- ✓ **基本观点：**认为童年经历的影响非常强大，并强调来访者当前社会环境、社会动机和人际关系的作用，个体生活经历的持续影响，自我的功能和自我概念的影响
- ✓ **常见疗法：**自由联想

一、心理咨询的常见流派

■ 精神分析/动力学取向

- ✓ **移情和反移情**是精神分析取向治疗的重要组成部分
- ✓ **移情**：来访者把过去生活中某个重要人物的情感、态度和属性转移到心理咨询师身上，并对心理咨询师相应地做出反应的过程。
- ✓ **移情的价值**：可以通过移情了解来访者对重要他人的情绪反应，引导来访者讲述过往产生重要影响的经历，揭示移情的意义，引导宣泄情感或产生顿悟，推动治疗。
- ✓ **反移情**：是咨询师对来访者的移情，即对来访者在其身上移情时的刺激给予反应，对反移情的觉察，是咨询师理解治疗关系互动特点的重要途径
- ✓ 两种形式：一致性反移情(对来访者)、互补性反移情(对来访者的重要他人)

一、心理咨询的常见流派

■ 行为主义取向

- ✓ 关注人的外显行为，认为人的异常行为是后天习得的
- ✓ **基本观点：**主张用条件作用原理和强化原理，去矫正与心理问题相联系的不良行为模式，采用与条件作用相关的技术来减少问题行为
- ✓ **常见疗法：**系统脱敏法、满灌疗法、厌恶疗法等

- **系统脱敏法：**引导求助者缓慢地暴露于导致神经症焦虑、恐惧的情境，并通过心理的放松状态来对抗这种焦虑情绪，从而达到消除焦虑或恐惧的目的。

1. 放松训练

2. 建立焦虑事件等级

3. 实施脱敏

(1) 进入放松状态：选择一处安静适宜、光线柔和、气温适度的环境，让求助者坐在舒适的座椅上，随着音乐的起伏开始进行肌肉放松训练。

(2) 想象脱敏训练：按照设计的焦虑等级表，由小到大逐级脱敏。首先让求助者想象最低等级的刺激事件或情境，当感到有些焦虑紧张时，令其停止想象，并全身放松。反复多次，直到不再焦虑紧张为止。如此逐级而上，直到对最高等级的刺激也不再感到焦虑紧张为止。

(3) 现实训练：让求助者真正接触让自己感到焦虑的事情，仍然是从最低级开始至最高级，逐级放松、脱敏训练，以不引起强烈的情绪反应为止，逐步改变。

- **满灌疗法：**让来访者想象或直接面对其最恐怖、最焦虑的场景，并且不会给来访者做任何放松训练，以迅速矫正来访者对恐怖、焦虑的错误认知，并消除由这种刺激引发的习惯性恐惧、焦虑反应。
 - ✓ 可以先使用想象暴露，再使用实景暴露
 - ✓ 时间短，解决问题比较干脆
 - ✓ 实施难度大，对病人身心冲击较大，须谨慎施用

- **厌恶疗法：**把需要戒除的目标行为与不愉快的惩罚刺激结合出现，通过厌恶性条件反射，以消退目标行为对来访者的吸引力，使症状消退。

一、心理咨询的常见流派

■ 认知主义取向

- ✓ 通过改变个体对其生活经历的思维方式，来减少问题行为
- ✓ **基本观点：**不良思维方式是导致异常行为模式和情绪困扰的原因。很多心理问题是由于个体在考虑与他人关系时，或者在面对特定事件时，运用了不良的思维方式
- ✓ **不良思维方式：**错误的前提假设、非理性的态度、僵化的规则意识等
- ✓ **思维记录表：**帮助来访者组织思维，以便做出更好的反应

一、心理咨询的常见流派

■ 人本主义取向

- ✓ **基本观点**：认为来访者是自己的专家，咨询师的任务是努力启发来访者，引导其对自己的思想和情感进一步了解，以找到解决问题的办法
- ✓ 认为咨访关系最重要，咨询师要真诚，对来访者共情、无条件积极关注和接纳等
- ✓ 特别注重**倾听**和**共情技术**

共情技术：指咨询师一边倾听来访者的叙述，一边进入来访者的精神世界，并能设身处地、感同身受地体验这个精神世界，然后跳出来访者的精神世界，言语准确地表达对来访者内心体验的理解。

来访案例：长期以来，我一直想和我的父亲和睦相处，但似乎呢？不论我如何努力，都行不通，他对我太严厉了，太有成见了。

初级共情：是对来访者表达或呈现出来的情绪感受、想法等的共情

回应：你尝试和父亲相处，但却不成功，你感到很沮丧

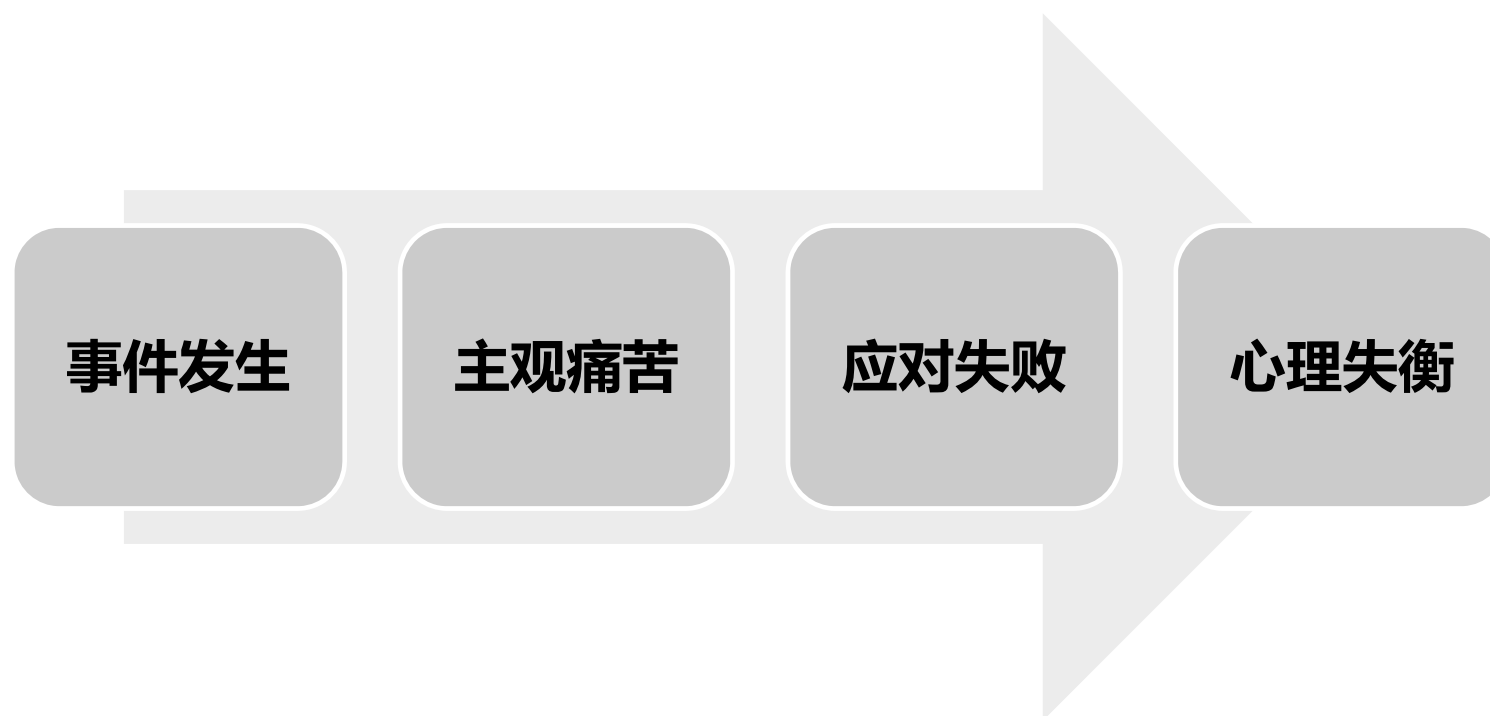
高级共情：不仅可以对来访者“明白表达”的感觉和想法进行回应，也对来访者未呈现出来的“隐含”感觉和想法也进行回应。

回应：你渴望和父亲拥有一个融洽的关系，希望他对你宽容温和一些。你也希望父亲能够看到你想改善你们关系的努力，希望能够得到父亲的回应与认可，但这一切却没有达成。你对自己的努力感到沮丧，对父亲感到失望，对自己感到很无助。

二、心理危机干预

■ 心理危机 (psychological crisis)

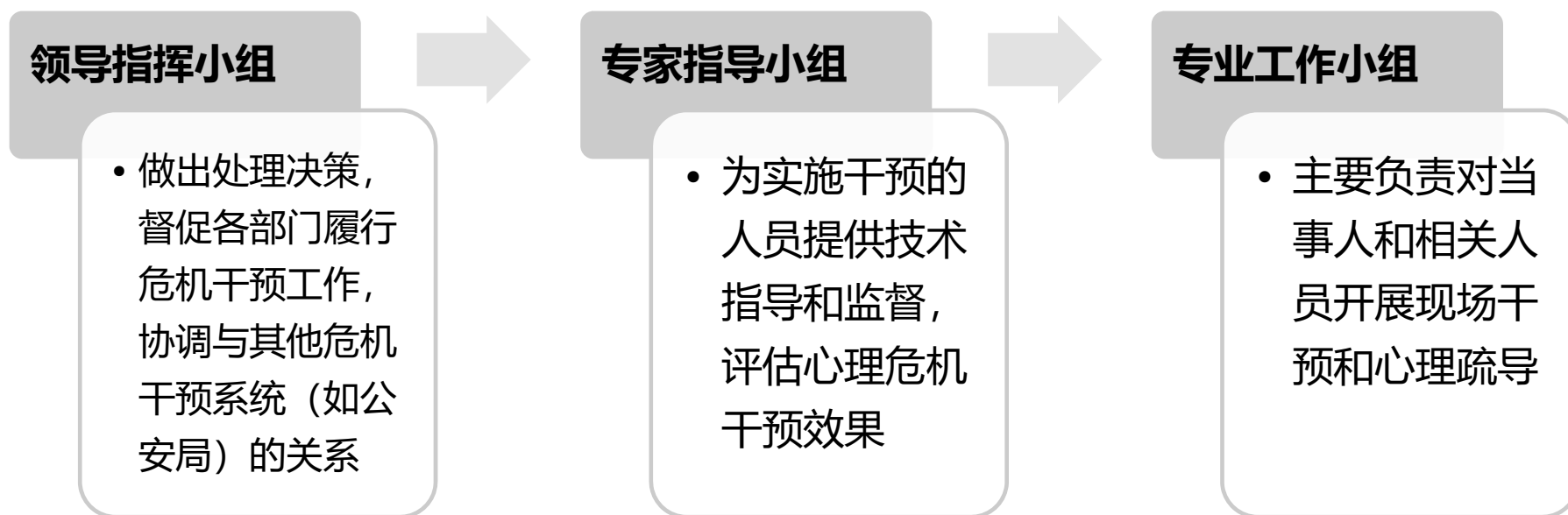
当个体遭遇突然或重大的危机事件，运用个人常规处理问题的方法无法解决时，出现的暂时心理失调状态。



二、心理危机干预

■ 心理危机干预

专业人员为处于困境和即将出现极端行为（如自杀、攻击等）的人提供及时的心理援助，以帮助其化解危机，恢复心理平衡。



二、心理危机干预

■ 心理危机干预基本流程

通常分为危机事件发生前、发生中和发生后**三个阶段**

	阶段	工作内容
一	危机事件发生前的预防和准备	① 传播心理健康和危机应对知识，提高个体心理适应水平 ② 组建心理危机干预团队，提前制定危机干预计划，培训相关人员 ③ 定期评估和排除个体的潜在心理危机，对风险人群开展辅导以提升其适应能力
二	第危机事件发生时的处理	心理危机干预团队迅速集合，启动心理危机干预计划，以化解危机为工作重点
三	危机事件发生后的干预及干预有效性评估	① 对当事人进行后期跟进，如实施长期的心理辅导，帮助其尽快走出阴影。 ② 对危机事件中的相关人员，先满足其基本生理需求，随后对其心理创伤水平进行评估，根据评估的严重程度开展针对性心理干预。 ③ 危机干预后需要定期评估干预效果，根据实际开展情况调整危机干预计划

本章小结

- 心理健康的定义及衡量标准
- 情绪及其生理机制、情绪的发展
- 常见心理问题的定义及其诊断标准
- 心理咨询的常见流派（精神分析/行为/认知/人本）
- 心理危机干预及基本流程

本章16个关键知识点

